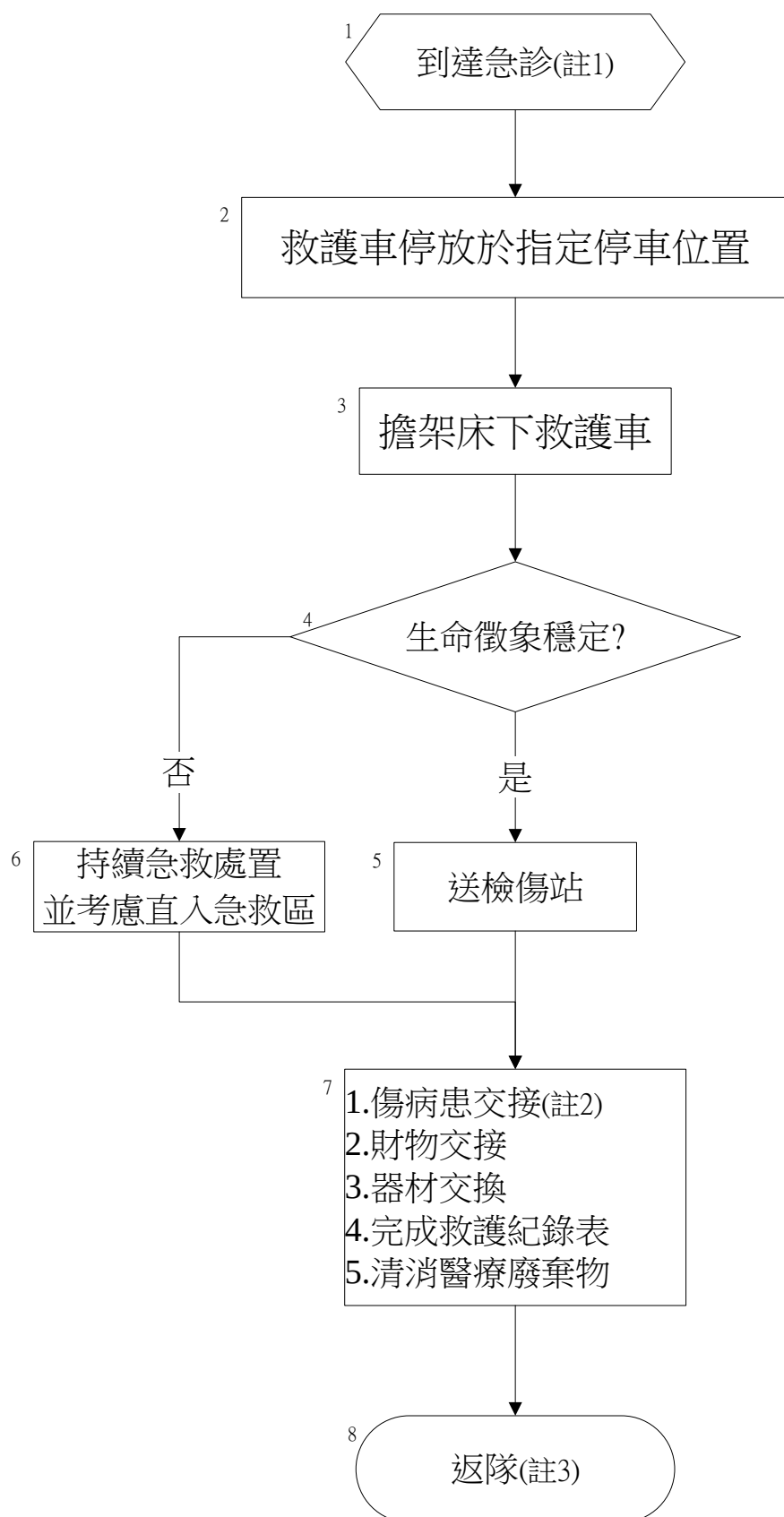


G7 到院傷病患交接

程 序



要 旨

- 一、到院後至醫護人員檢傷交接前，傷病患仍是屬於EMT照護的範疇。
- 二、現場重要訊息，如重要病史、評估處置、或嚴重創傷機轉，在檢傷交接時，應主動告知醫護人員。
- 三、運送疑似傳染病病患（例如發燒、疥蟲病患等）返隊清消依本局行政程序『【…】』

註 解

註1>

到達急診：

- 一、準備到達醫院前100公尺前，視交通情形關閉或調低警鳴器。
- 二、車上之氧氣治療應考量傷病患之呼吸狀況，必要時應延伸（攜帶3合1氧氣組或攜帶延伸用氧氣）至急救室內，傷病患交接後才可移除氧氣。

註2>

傷病患交接：

- 一、與醫師或護理人員交接傷病患之病情，並說明評估及急救處置情形（含輸液總量）。
- 二、救護人員如有執行下列表格之處置，皆應於處置後再次評估傷病患之症狀有無改善或惡化。到院後應主動將處置情形與再評估結果與醫護人員交接。

類別	處置
建立給藥途徑	靜脈輸液、骨內輸液、肌肉注射、吸入
輸液	生理食鹽水、10%葡萄糖注射液
呼吸道	聲門上呼吸道、氣管內管插管、嘗試異物排除
呼吸	氧氣治療
心血管	12 導程心電圖判讀結果、同步整流、經皮心臟節律器放置
外傷處置	止血帶、針刺減壓、開放性氣胸處置、開放性骨折、骨盆固定帶
協助使用藥物	協助使用 NTG、協助使用支氣管擴張劑
給予藥物	如 D50、A+B、Epinephrine、Atropine、Midazolam、NTG、Transamine、Penthrox…等

OHCA 傷病患	範例： I：__您好，我是__分隊的__，傷病患為__歲、男/女 S：於__時__分求救、主訴為__、過去(現在)病史(機轉)__、是/非目擊倒地、有/無旁觀者 CPR、初始心律__ A：可能 OHCA 原因__ R：我們 CPR__分鐘、去顫__次、給__藥、最後一次給藥時間與名稱；現在狀況
----------	--

三、救護紀錄表之填寫並交醫護人員簽名確認，並註記傷病患檢傷等級及病歷號登錄。

四、可交換之急救器材:頭頸部固定器、鏟式擔架(或長背板)、軀幹固定器（脫困器）、四肢用捲式護木。

五、若有重大災害（如:大量傷患、特殊災害）或特殊案件，於醫療處置與交接完成後即刻回報（傳）相關資訊至救災救護指揮中心，或適時於醫院彙整該案件之相關資訊，亦可將現場照片情況與醫護人員交接。

六、救護人員於現場處置傷病患之醫療廢棄物（如紗布、手套、生理食鹽水、包裝袋等），得放置於一般垃圾袋及感染性垃圾袋攜至救護車上集中處置，避免丟棄於現場，並於到達醫院後，將醫療廢棄物丟至醫院染污處置筒，若無染污之垃圾，應分類丟棄。

七、整理處置過程使用之器材若有染污時，醫院有適當地方清洗時，應先行處置。

註3>

返隊：

一、返隊時間關閉警示燈及警報器；返隊後有關案情之結報。

二、車輛器材之清潔消毒、除汙與耗材之補充，救護車一般清消時間原則以20分鐘為限，特殊案件之消毒請參考臺北市府消防局緊急救護勤務執行程序彙編-消毒指引。

三、車輛性能之檢查與油料補充。

四、各項器材歸位，並檢查其電力是否充足。(如 AED、MCPR、錄音筆、公用通訊手機…等等)。機械CPR(Mechanical CPR)，以下簡稱【M-CPR】

五、登錄各紀錄表、繕打電腦資料及救護紀錄表之掃描上傳；若使用電擊器，返隊後需立即下載資訊保存。